

Pomyśl, *sprawdź*, co się stało

Empiryczne testy magicznego myślenia. Dwa typy TAF, dwa eksperymenty, pewny dowód: *myśl* ≠ rzeczywistość.

CZAS: 15 min — oba eksperymenty Obsesje agresywne, seksualne, bluźniercze

ŹRÓDŁO: Rachman (1993, 1997); Shafran i wsp. (1996, TAF Scale); Zucker i wsp. (2002)

JAK UŻYWAĆ

Wykonaj **dwa eksperymenty** in-session: (1) **TAF moralna** — pomyśl celowo „*chcę, żeby [bliska osoba] zachorowała*”, obserwuj, czy zachorowała; (2) **TAF prawdopodobieństwa** — pomyśl mocno „*wygram na loterii*”, sprawdź wynik. Jeśli pozytywna myśl *nie działa*, dlaczego negatywna miałaby? Praca domowa: „*myśl* ≠ *fakt*; *myśleć* ≠ *chcieć*; *myśleć* ≠ *powodować*”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Eksperyment TAF (Rachman, 1993) **rozbija przekonanie** „*pomyśleć* = *zrobić/spowodować*”. Shafran i wsp. (1996, *TAF Scale*): TAF koreluje z nasileniem OCD $r = 0,45$ — silna korelacja. Zucker i wsp. (2002): **eksperymentalna indukcja TAF** u zdrowych osób *nasila* kompulsje OCD-podobne. Dwa typy: **TAF moralna** („*pomyślałem o skrzywdzeniu = jestem moralnie tak samo zły*”) + **TAF prawdopodobieństwa** („*pomyślałem o wypadku = zwiększyłem szansę*”). Bez rozbicia tej fuzji obsesja działa jak *fakt*, nie jak przelotna myśl. Najsilniejsze w obsesjach agresywnych, seksualnych, religijnych. Normalizacja (Rachman i de Silva, 1978): 90% populacji ma takie myśli — *pierwszy krok przed eksperymentem*.

01 ? Psychoedukacja — krok zerowy

90% ludzi ma niechciane, dziwne myśli (Rachman i de Silva, 1978). Pomyśleć o czymś *NIE jest tym samym*, co zrobić. Inaczej każdy, kto pomyślał o popchnięciu kogoś na torze metra, byłby **mordercą**; każdy, kto pomyślał o wypadku samochodu, byłby **sprawcą**.

Tak *nie jest*. Myśl jest **tylko myślą** — to, co liczy, to czyny.

02 ☉ Eksperyment 1 — TAF moralna

Hipoteza pacjenta: „*pomyślałem o krzywdzeniu kogoś = jestem moralnie taki sam jak ten, kto by to zrobić*”.

KROK	WYNIK
Pomyśl celowo, kilka razy : „ <i>Chcę, żeby moja mama zachorowała</i> ”.	Dyskomfort 0-100: ____
Zadzwoń do mamy lub do bliskiej osoby. Spytaj, jak się czuje.	Stan zdrowia: ____
Czy mama właśnie zachorowała ? Czy stała się bardziej chora?	TAK / NIE
Pomyśl jeszcze raz: „ <i>To była moja myśl</i> ”. Co to oznacza?	

Wniosek: myśl *nie spowodowała* choroby. Twoja świadoma intencja „*niech zachoruje*” **nie zadziałała**. Tym bardziej nieświadoma intruzja, której nawet nie chcesz, nie powoduje krzywdy.

03 Eksperyment 2 — TAF prawdopodobieństwa

Hipoteza pacjenta: „pomyślałem o wypadku = zwiększyłem szansę, że się stanie”.

KROK	WYNIK
Pomyśl mocno, intensywnie, kilka razy : „Wygram milion złotych na loterii w tym tygodniu”.	Pewność, że zwiększasz szansę: ____ %
Kup los lub sprawdź losowanie liczb w internecie za 7 dni.	Wynik: ____
Czy wygrałeś/-aś?	TAK / NIE
Wniosek dla siebie.	

PYTANIE KLUCZOWE

„Jeśli moja pozytywna myśl NIE zadziałała — dlaczego negatywna miałaby zadziałać? Czy mózg ma kanał tylko dla katastrof?”

04 Trzy formuły do codziennego użytku

1. „Myśl $\neq$ fakt.” Treść myśli to nie informacja o rzeczywistości. To migawka mózgu.

2. „Myśleć $\neq$ chcieć.” Intruzja przeciwna wartościom nie odzwierciedla pragnienia.

3. „Myśleć $\neq$ powodować.” Myśli nie wpływają na rzeczywistość fizyczną.

05 Praca domowa — przy intruzji

MOJA TYPOWA OBSESJA TAF

— konkretna myśl

TYP TAF

— moralna lub prawdopodobieństwa

KTÓRA Z TRZECH FORMUŁ ZASTOSUJĘ

— 1, 2 lub 3

Klucz: Shafran i wsp. (1996): TAF jest *specyficzne dla OCD* — niezwiązane z depresją ani lękiem ogólnym (po kontroli). Zucker i wsp. (2002): jednorazowa *indukcja TAF* u zdrowych osób (przez napisanie zdania o krzywdzie bliskiej osoby) **nasila zachowania OCD-podobne** w ciągu godziny. TAF jest **czynnikiem sprawczym**. Eksperyment *in-session* w obecności terapeuty daje silniejszy efekt niż samodzielna praca — szczególnie w obsesjach agresywnych/seksualnych, w których wstyd jest duży. Łącz z *ekspozycją wyobrażeniową* (skrypt z najgorszym scenariuszem) — dla obsesji typu „Pure O”.